

Sepse neonatal - precoce e tardia

Sepse neonatal precoce ("d72 h) liga-se a colonização perinatal (GBS, enterobactérias, Listeria). A tardia relaciona-se a ambiente/procedimentos (estafilococos, Gram"). Trate empiricamente sem atrasar coleta.

Sinais inespecíficos

Dica - Sinais inespecíficos

Recém-nascido 'não parece bem': apneia, letargia, má perfusão, hipotermia ou febre, distensão, glicemia instável. Não espere foco óbvio.

Ramificação etiológica clássica guia o ATB empírico e a investigação de foco.



Abordagem

- Culturas (hemocultura ± LCR conforme indicação) antes do ATB, sem atrasar
- ATB empírico precoce clássico: ampicilina + aminoglicosídeo
- Avaliar TORCH/meningite se clínica; suporte hemodinâmico e glicemia
- Fatores de risco precoce: CORIO, RPM prolongada, GBS materno, prematuridade

Tempo e germe

Janela | Germes típicos

Precoce | Streptococcus agalactiae, E. coli, Listeria

Tardia | S. epidermidis, S. aureus, Gram" hospitalares

Associada a cateter | Coagulase-negativos / Candida

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Listeria não é coberta por cefalosporina isolada. No esquema precoce, ampicilina (ou equivalente com atividade) é o ponto que a banca cobra.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Early-onset vs late-onset e fatores de risco (GBS, corioamnionite, prematuridade) guiam ATB empírico e a urgência no RN.

Early-onset: até ~72 h (transmissão vertical). Late-onset: após ~72 h (nosocomial/comunitária).

Sepse neonatal - tempo

Early vs late



GBS materno, corioamnionite, RPM prolongada e prematuridade elevam risco de sepse precoce.

Fatores de risco (early)

Transmissão vertical

- 1 Colonização GBS materna
- 2 Corioamnionite / febre intraparto
- 3 RPM prolongada
- 4 Prematuridade / baixo peso
- 5 Bacteriúria GBS na gestação
- 6 Irmão prévio com sepse GBS

Clinica inespecífica: apneia, letargia, hipo/hiperglicemia

Early × late (visão clássica)

| Early-onset | Late-onset

Tempo | < ~72 h | > ~72 h

Via | Vertical | Nosocomial/comunitária

Agentes | GBS, E. coli, Listeria | Staph, gram-neg, Candida...

Foco | Pneumonia/sepse/meningite | Bacteremia, meningite, ITU, foco hospitalar

Conduta

- Culturas + ATB empírico sem demora se sepse provável
- Early típico: ampicilina + aminoglicosídeo/cefalosporina 3ª (protocolo local)
- Avaliar LCR conforme estabilidade e suspeita de meningite
- Suporte: glicemia, temperatura, volume, ventilação

Armadilha

Atenção - Armadilha

RN 'só com dificuldade de mamar' e má perfusão pode estar séptico — clínica é inespecífica; não espere febre alta.

